

Уретропластика (восстановление уретры)

WARWIKI

Информация для пациента · Операция по устранению сужения уретры

Уретропластика — операция по восстановлению суженного, рубцово-изменённого участка уретры (мочеиспускательного канала), по которому моча выходит из организма. Сужение (стриктура) затрудняет или блокирует мочеиспускание; уретропластика восстанавливает нормальный просвет и является наиболее надёжным долгосрочным методом лечения. В этом листке объясняется, как проводится операция, как к ней подготовиться и чего ожидать.

Об этой операции

Стриктура — рубцовое сужение уретры, которое затрудняет опорожнение мочевого пузыря. В отличие от простого растяжения или рассечения (которые нередко дают рецидив), уретропластика **восстанавливает** нормальный просвет — наиболее надёжный метод с успехом около **85–95%**. Объём операции зависит от расположения и протяжённости сужения:

- **Разрез** может быть на **половом члене**, в промежности (область между мошонкой и анусом) или в обоих местах — в зависимости от расположения стриктуры.
- **Короткое** сужение можно **удалить и сшить здоровые концы уретры**.
- **Длинное** сужение **расширяют с помощью трансплантата** — обычно лоскута из слизистой щеки (об этом — отдельный листок).

Хирург объяснит, какой вариант подходит именно вам.

Это безопасно?

Уретропластика — хорошо отработанная, высокоэффективная операция; у большинства пациентов уретра остаётся открытой длительное время. Как и любое вмешательство, она несёт некоторый риск: кровотечение, инфекция или повторное сужение со временем (обычно поддающееся лечению). Нарушения эрекции или эякуляции возникают редко и, как правило, носят временный характер.

ТЕРМИНЫ

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из организма.

Стриктура

Рубцовое сужение уретры, замедляющее или блокирующее мочеиспускание.

Уретропластика

Операция по устранению сужения и восстановлению нормального просвета уретры.

Трансплантат

Небольшой лоскут собственной ткани (чаще со слизистой щеки) для расширения уретры.

Промежность

Область между мошонкой и анусом, где нередко делается разрез.

Катетер

Мягкая трубка, оставляемая в уретре примерно на 1–4 недели до заживления.

Уретрограмма

Рентгенологическое исследование уретры для проверки заживления перед удалением катетера.

Общая анестезия

Медикаментозный сон, при котором вы ничего не чувствуете во время операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинальной анестезией, поэтому вы ничего не почувствуете. При пробуждении в уретре уже будет катетер. Продолжительность зависит от объёма вмешательства, обычно 2–4 часа.

Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте все предоперационные рекомендации (голодание, отмена препаратов, в том числе антикоагулянтов).
- Анализ мочи** выявляет инфекцию — при её наличии сначала проводится лечение.
- Не курите** — курение замедляет заживление. Если планируется трансплантат из щеки, может быть рекомендована санация полости рта или визит к стоматологу.
- Рассчитывайте на **катетер после операции (около 1–4 недель)**; организуйте доставку домой.

Сообщите лечащей команде **заранее**, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете инфекцию мочевых путей либо кожи
- Перенесли операции на уретре, лучевую терапию или страдаете склеротическим лишаём (lichen sclerosus)

Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией (сон или потеря чувствительности от пояса вниз); вводятся антибиотики.
- 2 Хирург делает разрез над сужением (на половом члене, в промежности или в обоих местах) и открывает рубцовый участок.
- 3 Сужение устраняется — иссекается с наложением анастомоза или расширяется трансплантатом.
- 4 Устанавливается **катетер** для отведения мочи и защиты шва в период заживления; разрезы ушиваются.

После операции

- Вы выписываетесь домой с **катетером**, обычно на **1–4 недели**. Лечащая команда расскажет, как за ним ухаживать — не тяните за трубку.
- Отёк, синяки и небольшое **окрашивание мочи кровью** вокруг катетера в первые дни являются нормой.
- Избегайте тяжестей, натуживания, велосипеда и половых контактов** ~6 недель для заживления шва.
- Перед удалением катетера, как правило, выполняется **уретрограмма** для подтверждения заживления.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Катетер **выпал, засорился или перестал дренировать**
- Повышение температуры или озноб; нарастающее покраснение, боль или выделения в области разреза
- Обильное кровотечение или **невозможность помочиться** после удаления катетера

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Уретропластика восстанавливает суженную уретру — наиболее надёжный метод. Разрез может быть на половом члене, в промежности или в обоих местах; при необходимости берут трансплантат (чаще из слизистой щеки).
2. Подготовка: соблюдайте рекомендации по голоданию и приёму лекарств, заранее пролечите инфекцию, не курите, планируйте катетер после операции (1–4 недели).
3. Не удаляйте катетер самостоятельно — его снимут после уретрограммы. Несколько недель избегайте нагрузок и половых контактов.